

重症肌无力：不罕见的罕见病

□ 真德智

重症肌无力是一种看似罕见实则特定群体中并不少见的疾病,它悄无声息地影响患者的生活质量,让简单的日常动作变得异常艰难。简单说,重症肌无力是一种因神经和肌肉之间的通信障碍而引发肌肉无力和疲劳的自身免疫性疾病。尽管重症肌无力在大众视野中并不常见,但其患者群体跨越不同年龄层,从儿童到老年人均有可能患病。据统计,全球每年每百万人中就有3—30人新患此病,在我国每年每百万人中约有7人新患此病。这一数据揭示了重症肌无力作为“不罕见的罕见病”的独特性。尽管它的发病率相对较低,但据估计在全球范围内有70万患者正在饱受煎熬。

对重症肌无力的首次描述距今已超350年。1672年著名神经学家托马斯·威利斯在他的医学著作《动物的灵魂》中描述了如下症状:“这些劳动者早上还能稳健地工作,能举起锄头,能搬动重物,但到了中午,他们的力量就像流失掉了一样,甚至虚弱到不能举起手或抬起脚。我还认识一位女性,她的虚弱不仅表现在她的肢体上,还表现在她的语言上:她说说着,就像鱼一样哑了下去,甚至在一两个小时之后,她就再也不能说出任何一个字了。”

这段简单描述呈现出重症肌无力症状的重要特点和多样性、复杂性。重症肌无力最大的特点就是“波动性无力”,在每天早晨刚起床时,没有无力的症状或症状十分轻微,随着身体的活动,症状逐渐加重,其间通过休息还能有所缓解,经过一天的活动,到了傍晚症状就会明显比早晨严重,也就是所谓的“晨轻暮重”。而且,重症肌无力的症状呈多样性和复杂性,最常见的表现是眼部肌肉无力,导致眼睑下垂、视力模糊或复视;随着病情发展,可能累及咀嚼肌、咽喉肌和四肢的肌肉,造成言语不清和吞咽、洗脸、行走等困难,甚至需要他人辅助;更严重的是还会出现呼吸肌肉无力,呼吸不畅,甚至无法呼吸,危及生命。

在如今的快节奏社会里,很多人都会感觉疲乏劳累,这不是重症肌无力。因为病态的疲劳与普通疲劳不同,重症肌无力患者的疲劳感不会因休息而完全缓解,即使在静息状态下也会感到极度疲惫。重症肌无力的诊断方法已经十分成熟,医生通过如下几方面即可诊断:临床评估,详细询问患者的症状发展过程、家族史以及其他相关健康状况,了解患者的日常活动能力是否受限及其程度对于诊断至关重要;体格检查,通过观察患者的肌肉

力量、反射和协调性来进行初步评估,特别是对眼外肌、面部肌肉和四肢肌肉的功能进行检查;电生理检查,重复神经电刺激测试可以检测神经肌肉接头的功能状态,低频刺激下波幅递减超过10%通常提示存在传递障碍;抗体检测,检测血液中是否存在针对乙酰胆碱受体或其他相关蛋白如酪氨酸激酶 (MuSk) 的自身抗

体,乙酰胆碱受体抗体阳性率约为85%,而酪氨酸激酶抗体阳性率较低,但同样具有诊断价值;药理学试验,使用胆碱酯酶抑制剂如新斯的明或溴吡斯的明进行诊断性治疗,如果注射后症状明显改善,则支持重症肌无力的诊断;影像学检查,胸部计算机断层扫描 (CT) 用于检查胸腺异常,因为部分重症肌无力患者可能伴有胸腺瘤或胸腺增生。

目前,对于重症肌无力的治疗方法多种多样,效果也越来越好。

药物治疗

胆碱酯酶抑制剂:这类药物能够暂时增加神经肌肉突触间隙中的乙酰胆碱浓度,从而改善神经肌肉的信号传递。然而,长期使用可能会导致疗效下降。

免疫抑制剂:糖皮质激素是临床上使用最为广泛且有效的免疫抑制剂,就是我们常说的激素;还有其他非激素类的免疫抑制药物,这类免疫抑制剂可以减少免疫系统的攻



击行为,从而减轻重症肌无力的症状并防止病情恶化。但无论是激素类免疫抑制剂还是非激素类免疫抑制剂都有副作用,有些患者会因为副作用停用药物治疗。

生物靶向药物:近年来,一些新研发的生物靶向药物越来越多地应用在重症肌无力的治疗上。虽然这类生物靶向药物显现出比传统药物更好的疗效,但是也出现了一些特别的副作用,而且由于药物的靶向性,目前也只应用于一些难治性的重症肌无力患者的治疗。

非药物治疗

非药物治疗是针对体内的乙酰胆碱受体抗体治疗。神经肌肉接头是运动神经元与骨骼肌纤维之间的连接部位,主要由突触前膜、突触间隙和突触后膜组成。当神经冲动到达神经末梢也就是突触前膜时,会释放一种叫乙酰胆碱的物质,这种物质通过突触间隙到达肌肉细胞表面的突触后膜与乙酰胆碱受

体结合,从而引发肌肉收缩。

重症肌无力患者体内存在乙酰胆碱受体抗体,该抗体会与突触后膜的乙酰胆碱受体结合从而影响正常的乙酰胆碱结合,导致信号无法传递。这种乙酰胆碱受体抗体来源于胸腺组织。正常情况下胸腺在成年后就开始逐渐退化,有些人的胸腺退化不全或者退化后出现胸腺增生,这时免疫系统就会将其认定为异物组织,对它进行攻击,从而产生了乙酰胆碱受体抗体样物质,这些物质就会与突触后膜的乙酰胆碱受体结合,从而影响神经肌肉接头的信号传递,最终导致重症肌无力。

非药物治疗就是针对这个机制,直接减少或消除乙酰胆碱受体抗体而达到治疗的目的,方法如下。

胸腺切除术:75%—90%的重症肌无力患者伴有胸腺异常,其中85%为胸腺增生,10%—15%为胸腺瘤。对于伴有胸腺瘤或胸腺增生的重症肌无力患者,手术切除胸腺不仅有助于缓解症状,还可能降低疾病复发的风险,减少药物的用量和种类。

血浆置换与免疫吸附:在急性加重期,血浆置换可以迅速清除血液中的致病抗体,而免疫吸附则是一种更为精准的方法,专门针对特定抗体进行去除。但是这些方法不能长期使用,而且效果维持时间仅有数周,仍需应用其他方法长期治疗。

康复训练与心理支持

随着对重症肌无力的探索越来越深入,我们发现单纯治疗并不能完全缓解重症肌无力症状,很多患者需要在物理治疗师指导下

进行康复训练来帮助维持肌肉功能,延缓肌肉萎缩,从而达到对重症肌无力的更好治疗。

心理咨询和支持小组对于帮助患者应对情绪压力同样重要。治疗重症肌无力是一个长期而细致的过程,除了医疗干预外,患者的生活方式调整也很关键。保持良好的作息习惯,避免过度劳累,均衡饮食以增强免疫力,都是辅助治疗不可或缺的部分。同时,心理支持和社会理解对于提升患者的生活质量亦至关重要。

重症肌无力虽被视为“罕见病”,但其对患者生活质量的影响不容忽视。通过提高公众对该疾病的认识与理解,加强早期诊断与治疗,我们可以有效控制病情发展,改善患者的生活质量,帮助他们积极面对疾病带来的挑战。让我们携手努力,为重症肌无力患者创造更加美好的明天!

(作者单位:首都医科大学附属北京天坛医院)



似与不似 王 铎